Il test di Bolam

Diritto inglese degli illeciti civili | Guida allo studio | Competenza, cura e consenso informato

1. Un parametro professionale

Quando il convenuto esercita o dichiara una competenza speciale, il confronto è normalmente con un professionista ragionevolmente competente in quel campo. Una scelta terapeutica non viene giudicata semplicemente in base a ciò che farebbe una persona priva di formazione. Non si richiede la massima perizia possibile, ma la competenza appropriata.

La competenza deve riguardare l'attività contestata. Essere uno storico non innalza automaticamente lo standard per un incidente stradale estraneo alla professione. Occorre individuare compito e settore, senza attribuire responsabilità speciale a ogni azione di una persona qualificata.

2. Il principio di Bolam

Bolam v Friern Hospital Management Committee [1957] 1 WLR 582 chiarisce che un professionista non è negligente soltanto perché altri sceglierebbero diversamente, se segue una pratica considerata corretta da un gruppo responsabile di professionisti con la competenza pertinente.

Il gruppo non deve essere necessariamente maggioritario. Tuttavia, trovare qualcuno disposto a sostenere il convenuto non garantisce una difesa. L'opinione deve essere responsabile e logicamente sostenibile, come chiarito da Bolitho.

3. La valutazione resta oggettiva

Scegliere il parametro professionale non lo trasforma nello standard personale del convenuto. Non basta chiedere "questo medico ha fatto del suo meglio?" o "credeva sinceramente fosse giusto?". Il giudice valuta la condotta rispetto allo standard professionale applicabile.

> Competenza pertinente → professionista competente → pratica responsabile → controllo logico. I fatti individuano il parametro; ciò non rende il test puramente soggettivo.

Nomi corretti: Bolam e Friern. Uno standard adatto al lavoro professionale non è semplicemente un "punteggio più alto" per qualsiasi attività: riguarda la competenza concretamente esercitata.

Bolam: il caso originario

1. I fatti: terapia elettroconvulsivante

Il signor Bolam ricevette una **terapia elettroconvulsivante (ECT)**, che induce una crisi convulsiva mediante corrente elettrica. Subì gravi fratture. Le accuse riguardavano l'assenza di farmaci miorilassanti, il contenimento fisico e la mancata informazione sul rischio di frattura.

I medici esperti non concordavano sulla pratica adeguata all'epoca, compresi rischi e benefici di miorilassanti e contenimento. Il caso non riguardava quindi soltanto l'informazione, ma anche l'esecuzione del trattamento.

2. Chi vinse e perché?

Vinse il comitato di gestione ospedaliera convenuto. McNair J illustrò alla giuria lo standard professionale e il rilievo di un'opinione medica responsabile. La giuria pronunciò un verdetto per i convenuti. La lesione da sola non dimostrava un trattamento negligente.

Il contrasto tra due orientamenti professionali responsabili non rende, di per sé, negligente uno dei due. D'altra parte, lo status professionale non protegge l'imprudenza: la condotta concreta deve rispettare lo standard.

3. Come usare oggi il caso

Bolam resta importante per diagnosi e trattamento clinico, con il controllo previsto da Bolitho. Il suo approccio storico agli avvertimenti non va presentato come regola generale attuale sul consenso informato. Montgomery richiede un'analisi distinta dei rischi rilevanti e delle alternative ragionevoli.

Esempio inventato: due tecniche sono entrambe sostenute da opinioni responsabili e logicamente difendibili. Sceglierne una non dimostra breach solo perché un altro esperto preferisce l'altra. Eseguire male la tecnica scelta è una questione diversa.

> Tre domande distinte: la scelta clinica era professionalmente difendibile? È stata eseguita con competenza? Il paziente era adeguatamente informato? Una risposta non risolve automaticamente le altre.

L'esempio è inventato. Bolam riguarda la pratica degli anni Cinquanta: è storia giuridica, non un'indicazione clinica attuale sull'ECT. Il verdetto storico non sostituisce le conoscenze mediche odierne.

Bolitho: una base logica

1. Il giudice conserva un ruolo

In **Bolitho v City and Hackney Health Authority [1998] AC 232**, la House of Lords chiarì che il sostegno di esperti non è conclusivo soltanto perché sincero. L'opinione deve avere una base logica, inclusa una valutazione difendibile dei rischi e benefici pertinenti.

Ciò non permette al giudice di sostituire la competenza medica con preferenze personali. Se due opinioni sono logicamente sostenibili, non basta preferirne una per respingere l'altra. Il rigetto di un'opinione competente fu descritto come eccezionale.

2. Fatti ed esito

Un bambino subì un collasso respiratorio catastrofico. Una dottoressa aveva negligentemente omesso di presentarsi dopo essere stata chiamata. Occorreva inoltre stabilire se la visita avrebbe condotto all'intubazione e se non intubare sarebbe stato a sua volta negligente.

Vinse l'autorità sanitaria in appello alla House of Lords. L'opinione favorevole a non intubare non risultava illogica. Non era dimostrato che la mancata visita avesse causato il danno: una scelta difendibile di non intubare non avrebbe impedito il collasso.

3. Perché conta per lo studio

Breach e causalità sono collegate ma distinte. Provare un'omissione negligente non prova che abbia causato la lesione. Viceversa, il convenuto non può negare la causalità semplicemente dicendo che avrebbe comunque commesso un altro atto negligente.

Esempio inventato: un esperto sostiene l'omissione di una precauzione semplice, ma non spiega coerentemente perché ignorare un rischio grave noto. Il giudice può esaminare se l'opinione sia davvero responsabile. "Un collega è d'accordo" non è il test completo.

> Bolam attribuisce peso alla pratica professionale responsabile. Bolitho richiede che superi un'analisi logica. Nessuno dei due garantisce una difesa ogni volta che un esperto sostiene il convenuto.

Bolitho fu deciso nel 1997 e pubblicato in [1998] AC 232. È una precisazione aggiunta alla trascrizione. L'esempio della precauzione è inventato, non un ulteriore fatto del caso.

Montgomery: la scelta del paziente

1. Una domanda diversa: scelta informata

Montgomery v Lanarkshire Health Board [2015] UKSC 11 riguardava una donna diabetica non informata del rischio di distocia di spalla nel parto vaginale: le spalle del bambino rimangono bloccate. La complicazione si verificò e il figlio subì gravi lesioni.

La signora Montgomery vinse davanti alla Supreme Court. La dottoressa avrebbe dovuto discutere il rischio rilevante e l'opzione del cesareo. Il giudice concluse inoltre che, correttamente informata, la madre avrebbe scelto il cesareo, evitando la lesione.

2. Che cos'è un rischio rilevante?

Il medico deve usare ragionevole diligenza per informare sui rischi rilevanti del trattamento raccomandato e sulle alternative ragionevoli. Il rischio è rilevante se una persona ragionevole nella posizione del paziente probabilmente gli attribuirebbe importanza, **oppure** se il medico sa o dovrebbe ragionevolmente sapere che proprio quel paziente lo farebbe.

Non conta soltanto ciò che altri medici comunicano di solito. È protetta la decisione del paziente. Vi sono un aspetto riferito al paziente ragionevole e uno al paziente concreto; non decide la preferenza soggettiva del medico. Serve dialogo comprensibile, non soltanto una firma.

3. Precisazione successiva: McCulloch

In **McCulloch v Forth Valley Health Board [2023] UKSC 26**, i familiari sostenevano che un'opzione farmacologica dovesse essere discussa. **Vinse l'ente sanitario.** L'individuazione delle alternative clinicamente ragionevoli segue il test professionale, soggetto a Bolitho. Montgomery regola la comunicazione dei rischi rilevanti e delle opzioni ragionevoli; non ogni terapia immaginabile va offerta.

> Diagnosi/trattamento: Bolam, con Bolitho. Informazione sui rischi rilevanti: Montgomery. Ragionevolezza clinica di un'alternativa: valutazione professionale chiarita in McCulloch.

Nome corretto: Lanarkshire, non Lancashire. I casi della Supreme Court provengono dalla Scozia ma chiariscono principi usati in Inghilterra e Galles. Le strette eccezioni per grave danno da comunicazione o necessità urgente non consentono di tacere solo per evitare un rifiuto.

Verifica la comprensione

1. Perché non confrontare un medico con un profano?
Risposta: L’attività richiede competenza professionale. Il parametro è un professionista ragionevolmente competente nella capacità pertinente.

2. Il parametro professionale rende soggettivo il test?
Risposta: No. I fatti individuano il parametro; convinzione personale e massimo impegno individuale non sostituiscono lo standard oggettivo.

3. Chi vinse in Bolam?
Risposta: Il comitato ospedaliero. La giuria decise per i convenuti dopo le istruzioni sullo standard professionale; la lesione non provava da sola negligence.

4. Un esperto favorevole garantisce una difesa?
Risposta: No. La condotta deve seguire una pratica responsabile e logicamente sostenibile.

5. Che cosa aggiunse Bolitho e chi vinse?
Risposta: Confermò il controllo sulla base logica dell’opinione. Vinse l’autorità sanitaria: non intubare era difendibile e la causalità non era provata.

6. Quando un rischio è rilevante secondo Montgomery?
Risposta: Se una persona ragionevole nella posizione del paziente probabilmente lo considererebbe importante, oppure il medico dovrebbe saperlo del paziente concreto. Basta una delle due vie.

7. Montgomery eliminò Bolam per ogni questione medica?
Risposta: No. Modificò l’informazione sui rischi. Il giudizio clinico resta distinto; McCulloch riguarda le alternative ragionevoli.

> Sequenza: identifica il compito → distingui giudizio clinico e informazione → scegli il test → valuta prove e ragioni → concludi su breach → verifica causalità e danno risarcibile.

Fonti

Basato sulla trascrizione Law Academy fornita, correggendo nomi e distinzioni giuridiche. Chiarimenti aggiunti: Bolitho e McCulloch. Fonti primarie: Bolam [1957] 1 WLR 582, 586-588; Bolitho [1998] AC 232. Montgomery [2015] UKSC 11, paras 87-90 and 103-105; McCulloch [2023] UKSC 26. Gli esempi inventati sono segnalati.